

Valvulopatías Generalidades

Introducción a las Valvulopatías

Las valvulopatías comprenden todas las enfermedades que afectan las válvulas cardíacas, ya sea impidiendo su apertura correcta (**estenosis**) o fallando en su cierre total (**insuficiencia** o **regurgitación**). El manejo general depende críticamente de la severidad hemodinámica y la presencia de síntomas.

Presentación Clínica General

La clínica de las valvulopatías es variada, pero suele pivotar sobre dos ejes principales:

- **Insuficiencia Cardíaca (IC):** Dependiendo de la válvula afectada, el paciente presentará síntomas de **Insuficiencia Cardíaca** izquierda (congestión pulmonar, disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna) o derecha (edema de extremidades, ingurgitación yugular, ascitis).
- **Presencia de Soplos:** Es el signo cardinal. Las características del soplo (foco de máxima auscultación, irradiación, relación con el ciclo cardíaco) permiten orientar el diagnóstico etiológico.

NOTA CLÍNICA

La fisiopatología de los síntomas depende de si la afectación es retrógrada (hacia los pulmones en el caso de la mitral/aórtica) o si hay una caída del gasto cardíaco anterógrado.

Diagnóstico

El estándar de oro para el diagnóstico de cualquier valvulopatía es el **Ecocardiograma**. Este estudio permite determinar tres pilares fundamentales: - La válvula específicamente afectada. - El mecanismo del daño (estenosis vs. insuficiencia). - La **severidad** (leve, moderada o severa) mediante mediciones de áreas valvulares y gradientes de presión.

Algoritmo de Tratamiento General

El manejo se define por la combinación de severidad ecocardiográfica y estado clínico del paciente:

- **Paciente Asintomático + Valvulopatía Leve/Moderada:** Se opta por **tratamiento médico general** de la insuficiencia cardíaca (según corresponda):
 - *IECA / ARA II.*
 - Diuréticos (para manejo de congestión).
 - *Betabloqueadores.*
- **Paciente Sintomático O Valvulopatía Severa:** *Se requiere intervención quirúrgica.*
- **Reparación (Valvuloplastia):** Se prefiere si la anatomía de la válvula lo permite, para conservar el tejido propio.
- **Reemplazo Valvular:** *Cambio de la válvula dañada por una prótesis.*

PERLA CLÍNICA EUNACOM

En el EUNACOM, si un paciente con valvulopatía severa presenta síntomas (disnea, síncope, angina), la respuesta suele ser siempre la resolución quirúrgica.

Prótesis Valvulares: Tipos y Selección

Cuando la reparación no es posible, se opta por el reemplazo con prótesis. Existen dos tipos principales:

TABLA 1.27.1: CARACTERÍSTICA VS PRÓTESIS BIOLÓGICA

CARACTERÍSTICA	PRÓTESIS BIOLÓGICA	PRÓTESIS MECÁNICA
Origen	Porcino, bovino o pericardio humano.	Metálicas / Sintéticas.
Durabilidad	Limitada (aprox. 10 años).	Muy alta (habitualmente "de por vida").
Anticoagulación	No requiere (solo los primeros meses).	Obligatoria y de por vida.
Fármaco usado	N/A	Cumarínicos (Acenocumarol/Warfarina).
Riesgo	Re-intervención por degeneración.	Fenómenos embólicos o hemorrágicos.

Criterios de Selección (Edad y Comorbilidades)

La elección de la prótesis depende fundamentalmente de la edad y la capacidad del paciente para recibir anticoagulación:

Prótesis Mecánicas: Se prefieren en pacientes jóvenes. En posición **Aórtica:** Generalmente en menores de 55 años. En posición **Mitral:** Generalmente en menores de 70 años (debido a que las biológicas mitrales duran menos tiempo). Requieren un **INR más alto** (rango entre 3.0 y 3.5, pudiendo llegar a 4.0 en casos específicos).

Prótesis Biológicas: Se prefieren en adultos mayores (donde la expectativa de vida es menor a la duración de la prótesis, ej. >75-80 años). * Se eligen si existe **contraindicación absoluta para la anticoagulación** (ej. riesgo alto de sangrado, alergias, deseo de embarazo en el corto plazo aunque es discutible).

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Nunca se debe colocar una prótesis mecánica en un paciente que no puede o no quiere cumplir con el tratamiento anticoagulante (TACO). El riesgo de trombosis de la prótesis y embolia sistémica es extremadamente alto y potencialmente mortal.

Resumen de Perlas para el Examen

- **Ecocardiograma:** Siempre es el primer paso diagnóstico ante la sospecha de soplo patológico. - **Tratamiento médico:** Solo es paliativo o para casos no severos/asintomáticos. - **Cirugía:** Es el tratamiento definitivo para valvulopatías severas o sintomáticas. - **Anticoagulación:** Las prótesis mecánicas exigen el uso de antagonistas de la vitamina K (Cumarínicos). Los nuevos anticoagulantes orales (DOACs) **no** están indicados en prótesis mecánicas.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Mujer de 55 años consulta por disnea progresiva. A la auscultación se encuentra un soplo diastólico de baja frecuencia en ápex con chasquido de apertura. Se solicita ecocardiograma que muestra área valvular mitral de 1.2 cm²."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Estenosis Mitral con área < 1.5 cm² es severa. Etiología más frecuente: Reumática. Clasificación de soplos: Sistólicos (Estenosis Aórtica, Insuficiencia Mitral) vs Diastólicos (Estenosis Mitral, Insuficiencia Aórtica). El ecocardiograma es el gold standard para diagnóstico y severidad.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las valvulopatías se clasifican en estenosis (obstrucción al flujo) e insuficiencia (flujo retrógrado)
- La causa más frecuente en países desarrollados es degenerativa; en países en desarrollo es reumática
- La estenosis genera sobrecarga de presión e hipertrofia concéntrica; la insuficiencia genera sobrecarga de volumen y dilatación
- Los soplos diastólicos siempre son patológicos
- El ecocardiograma transtorácico es el examen de elección para diagnóstico y cuantificación
- La intervención se indica en valvulopatía severa sintomática o con disfunción ventricular

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (VALVULOPATÍAS GENERALIDADES)**PREGUNTA 1**

Paciente de 72 años consulta por disnea de esfuerzos progresiva. Al examen se ausculta un soplo sistólico eyectivo en foco aórtico con irradiación a carótidas. ¿Cuál es el examen de elección para confirmar el diagnóstico y cuantificar la severidad?

- A)** Radiografía de tórax
- B)** Electrocardiograma
- C)** Ecocardiograma transtorácico
- D)** Cateterismo cardíaco
- E)** Resonancia magnética cardíaca

PREGUNTA 2

¿Cuál de los siguientes soplos es siempre patológico?

- A)** Soplo sistólico eyectivo grado II en foco pulmonar
- B)** Soplo diastólico en foco aórtico
- C)** Soplo sistólico que desaparece con Valsalva
- D)** Soplo sistólico en embarazada
- E)** Soplo continuo venoso cervical

PREGUNTA 3

Respecto a la fisiopatología de las valvulopatías, ¿cuál afirmación es correcta?

- A)** La estenosis genera sobrecarga de volumen
- B)** La insuficiencia genera hipertrofia concéntrica
- C)** La estenosis produce hipertrofia concéntrica de la cámara proximal
- D)** Las valvulopatías agudas siempre son mejor toleradas que las crónicas
- E)** La causa más frecuente en jóvenes es la degenerativa

RESUMEN: VALVULOPATÍAS GENERALIDADES

Las valvulopatías son enfermedades de las válvulas cardíacas que alteran el flujo sanguíneo normal. Se clasifican en estenosis, cuando la válvula no se abre completamente, e insuficiencia o regurgitación, cuando la válvula no cierra de forma adecuada. Las cuatro válvulas cardíacas pueden verse afectadas, siendo las valvulopatías izquierdas (mitral y aórtica) las más frecuentes y clínicamente relevantes. El diagnóstico se basa en la auscultación cardíaca sistemática y el ecocardiograma transtorácico como herramienta principal. Los soplos sistólicos se producen por estenosis aórtica, estenosis pulmonar, insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspídea. Los soplos diastólicos se producen por insuficiencia aórtica, insuficiencia pulmonar, estenosis mitral y estenosis tricuspídea. La severidad se clasifica en leve, moderada y severa según parámetros ecocardiográficos específicos. El tratamiento depende de la severidad y la repercusión hemodinámica. Las valvulopatías leves a moderadas asintomáticas se manejan con seguimiento periódico. La intervención quirúrgica o percutánea se indica en valvulopatías severas sintomáticas o con disfunción ventricular. Las opciones incluyen reparación valvular, reemplazo por prótesis mecánica o biológica, y procedimientos percutáneos como TAVI o MitraClip.